

DPP - descolamento prematuro de placenta

DPP é a separação prematura da placenta normalmente inserida. Quadro clássico: dor uterina, hipertonia e sangramento (pode ser oculto). Gravidade materna/fetal define resolução.

Fatores de risco

Lembre - Fatores de risco

HAS/pré-eclâmpsia, trauma, tabagismo, uso de cocaína, rotura prematura, polidrâmnio, DPP prévia, multiparidade.

Fluxo: clínica !' ABCD materno + monitoramento fetal !' cesariana/parto conforme vitalidade e dilatação.

DPP na emergencia

Suspeitar -> reanimar -> resolver gestacao

Suspeitar

dor + hipertonia +/- sangramento

Reanimar

2 acessos / sangue / coagulacao

Resolver

cesarea ou parto vaginal

Avaliação e conduta

- Sinais: útero lenhoso, dor contínua, tontura/choque desproporcional ao sangramento visível
- Lab: hemograma, coagulograma, tipagem; CIVD é complicação temida
- USG não exclui DPP — diagnóstico clínico
- Feto vivo + materno instável / sofrimento: cesárea; óbito fetal pode permitir vaginal se mãe estável

DPP vs placenta prévia

Achado | DPP | Prévia

Dor | Presente | Ausente (clássico)

Útero | Hipertônico | Eutônico

Sangramento | Escuro ± oculto | Vermelho vivo, indolor

Toque | Evitar se prévia suspeita | Contraindicado até excluir

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Sangramento externo pode ser pequeno na DPP grave — o hematoma fica retido. Trate o choque e a coagulopatia; não se tranquilize só com 'pouco sangramento na vulva'.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1